Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Submandibuler Gland Eksizyonu

Çene altı tükürük bezinin çıkarılması

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Taraf: ☐ Sağ ☐ Sol

Ameliyat nedeni: ☐ Tükürük bezi taşı / tekrarlayan iltihap ☐ Bez içinde kitle ☐ Diğer _____

Sinir monitörizasyonu: ☐ Kullanılacak ☐ Kullanılmayacak

Görüntüleme / biyopsi sonucu: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Submandibuler bez, alt çenenin hemen altında, her iki tarafta bulunan ve ağız içine tükürük salgılayan bir tükürük bezidir. Ağızdaki tükürüğün önemli bir kısmını üretir; ancak diğer tarafta aynı bez ile kulak önündeki ve dil altındaki tükürük bezleri çalışmaya devam ettiği için **tek bezin çıkarılması çoğu hastada ağız kuruluğuna yol açmaz**.

Bu ameliyat en sık **tükürük bezi taşları** ve bunlara bağlı **tekrarlayan şişlik ve iltihaplar** nedeniyle yapılır. Taş, tükürüğün ağza akmasını engeller; yemek yerken çene altında ağrılı şişlik ve tekrarlayan enfeksiyonlar olur. Daha az sıklıkla bez içinde gelişen **kitleler (tümörler)** ameliyatı gerektirir. Submandibuler bez kitlelerinde kötü huylu tümör oranı parotis bezine göre daha yüksektir; bu nedenle kesin tanı için bezin çıkarılması ve patolojik inceleme önemlidir.

Bezin çevresinden alt dudağı hareket ettiren sinir dalı, dile his veren sinir ve dili hareket ettiren sinir geçer. Ameliyatın amacı, bu sinirleri koruyarak bezi tamamen çıkarmaktır.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılır.

1. **Kesi:** Alt çene kemiğinin yaklaşık 2–3 cm altında, boyundaki doğal bir cilt çizgisine paralel, genellikle 4–6 cm uzunluğunda bir kesi yapılır. Kesinin çeneden yeterince aşağıda yapılması, alt dudağı hareket ettiren sinir dalını korumaya yardımcı olur.
2. **Sinirlerin korunması:** Cilt altındaki ince kas tabakası (platisma) geçilir. Alt dudağı hareket ettiren sinir dalı (marjinal mandibuler sinir) görülerek veya güvenli bir katmanda kalınarak korunur.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3. **Bezin çıkarılması:** Bez çevre dokulardan ayrılır; bezi besleyen damarlar bağlanır. Bezin tükürük kanalı, dile his veren sinirden (lingual sinir) dikkatle ayrılarak bağlanır ve kesilir. Dili hareket ettiren sinir (hipoglossal sinir) korunur. Kanalda taş varsa mümkün olduğunca kanalın uzak kısmı da çıkarılır.
4. **Patolojik inceleme:** Çıkarılan bez patolojiye gönderilir; sonuç genellikle 1–2 hafta içinde çıkar.
5. **Kapatma:** Kanama kontrolü yapılır, genellikle ince bir **dren** yerleştirilir ve cilt estetik dikişlerle kapatılır.

Ağız içinde, kanalın ağza açıldığı yere yakın bir taş varsa bu taş bazen ayrıca ağız içinden de çıkarılabilir. Bu durum ameliyat öncesinde sizinle konuşulur.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 1–2 saat	Genellikle 1 gece; dren çıkınca taburculuk

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Taşa bağlı tekrarlayan ağrılı şişliklerin ve iltihapların sona ermesi
- Tekrarlayan antibiyotik kullanımı ihtiyacının ortadan kalkması
- Bezdeki kitlenin çıkarılması ve kesin tanının konulması

Taş ve kronik iltihap nedeniyle yapılan ameliyatlardan sonra hastaların **%90'ından fazlasında** şikâyetler tamamen geçer. Kanalın ağız içinde kalan kısmında taş kalırsa veya yeni taş oluşursa nadiren ağız tabanında şişlik devam edebilir. İyi huylu kitlelerde ameliyat genellikle kalıcı tedavidir; kötü huylu tümörlerde ek tedavi gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **İlaç ve destek tedavisi:** Bol sıvı, ekşi tatlarla tükürük artırma, masaj, sıcak uygulama ve iltihap dönemlerinde antibiyotik. Şikâyetleri hafifletebilir ancak taşı ortadan kaldırmaz.
- **Ağız içinden taş çıkarılması:** Kanalın ağza yakın kısmındaki ve elle hissedilen taşlar ağız içinden küçük bir kesi ile çıkarılabilir; bez korunur.
- **Tükürük kanalı endoskopisi (siyalendoskopi):** Uygun boyut ve konumdaki taşlar ince bir endoskopla kanal içinden çıkarılabilir; her merkezde ve her taş için uygun değildir.
- **Takip:** Küçük ve iyi huylu olduğu düşünülen kitlelerde nadiren izlem konuşulabilir; ancak bu bezde kesin tanı için cerrahi genellikle önerilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa taşa bağlı şişlik ve iltihaplar tekrarlamaya devam edebilir; nadiren bez çevresinde apse (iltihap birikimi) gelişebilir ve acil tedavi gerekebilir. Bezde kitle varsa kesin tanı konamaz; kötü huylu bir tümör tedavi edilmezse ilerleyebilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri ve görüntüleme (ultrason, gerekirse BT/MR) yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).
- Bezde aktif iltihap varsa ameliyat genellikle iltihap tedavi edildikten sonra planlanır.
- Erkek hastalarda kesi bölgesindeki sakal ameliyat günü kısaltılabilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 24–48 saat	Çene altında hafif–orta ağrı, gerginlik ve şişlik olur; ağrı kesicilerle kontrol edilir. Yutkunurken hafif rahatsızlık olabilir. Dren genellikle 1. gün çekilir. Başınızı yüksekte tutarak yatmanız önerilir. Yumuşak gıdalarla beslenmeye hemen başlanabilir.
1. hafta	Günlük işlerinize dönebilirsiniz. Dikişler genellikle **5–7. günlerde** alınır. Kesinin üstünde, çene kenarında ve kesi çevresinde uyuşukluk normaldir. Patoloji sonucu bu dönemde veya kısa süre sonra sizinle paylaşılır.
2–4. haftalar	Masa başı işe genellikle 1 hafta içinde dönülür. Ağır egzersiz ve ağır kaldırma yaklaşık **2 hafta** ertelenmelidir. Kesi yerindeki sertlik ve hafif şişlik giderek azalır.
2–6. aylar	İz giderek solar ve çoğu zaman boyun çizgisinde belirsizleşir. Geçici sinir güçsüzlüğü veya his azalması olduysa büyük çoğunlukla bu dönemde düzelir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Çene altında ağrı, gerginlik ve şişlik; yutkunurken hafif rahatsızlık
- Kesi çevresinde ve altında cilt uyuşukluğu
- Boyunda kesi izi (zamanla solar)

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Alt dudakta geçici güçsüzlük** — Alt dudağı aşağı çeken sinir dalının (marjinal mandibuler sinir) ameliyat sırasında gerilmesine bağlı olarak, yaklaşık 100 hastadan **10–20'sinde** gülümserken veya konuşurken alt dudağın o tarafında hafif asimetri olur. Görünüşe yönelik bir sorundur, yeme-içmeyi genellikle etkilemez ve çoğunlukla **haftalar–birkaç ay içinde** düzelir.
- **Kesi bölgesinde sertlik ve uyuşukluk** — İlk haftalarda kesi altında sertlik ve his azalması sıktır; aylar içinde azalır.

Seyrek görülen durumlar

- **Kanama ve hematom** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** cilt altında kan birikebilir. Büyükse ameliyathanede boşaltılması ve kanamanın durdurulması gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Yara enfeksiyonu** — Özellikle iltihaplı bezlerde 100 hastada **1–3** oranında görülebilir; genellikle antibiyotikle düzelir, nadiren iltihabın boşaltılması gerekir.
- **Dil yarısında his azalması** — Dile his veren sinirin (lingual sinir) etkilenmesine bağlı olarak dilin o tarafında uyuşukluk veya karıncalanma, 100 hastada yaklaşık **1–3** oranında görülür. Çoğunlukla geçicidir; nadiren kalıcı olabilir ve tat almayı da etkileyebilir.
- **Sıvı birikimi (serom)** — Kesi altında sıvı birikmesi; genellikle iğne ile boşaltma ve baskılı pansumanla düzelir.
- **Kanalda kalan taş** — Tükürük kanalının ağız içinde kalan kısmında taş kalabilir veya yeniden oluşabilir; ağız tabanında şişlik veya iltihap yapabilir. Gerekirse ağız içinden küçük bir işlemle çıkarılır.
- **Belirgin veya kalın iz** — Kişisel yatkınlığa bağlı olarak iz kalınlaşabilir veya belirgin kalabilir; iz tedavileri uygulanabilir.
- **Çene altında çöküklük** — Bezin yerinde hafif çukurluk ve iki taraf arasında fark oluşabilir; genellikle belirgin değildir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Alt dudakta kalıcı güçsüzlük** — 100 hastadan **yaklaşık 1–3'ünde** veya daha azında alt dudağın o tarafında kalıcı hareket kısıtlılığı ve gülümsemede asimetri kalabilir. Belirgin olursa botulinum toksini ile karşı tarafın dengelenmesi gibi tedaviler uygulanabilir.
- **Dil hareketlerinde güçsüzlük** — Dili hareket ettiren sinirin (hipoglossal sinir) etkilenmesi **çok nadirdir**. Gelişirse dilin o tarafında güçsüzlük, konuşma ve yutmada zorluk olabilir; kalıcı hasar durumunda konuşma-yutma terapisi gerekebilir.
- **Boyunda büyük hematom ve nefes yolunun etkilenmesi** — Çok nadiren hızla büyüyen kan birikimi boyunda baskı yaparak yutma veya **nefes alma güçlüğüne** yol açabilir. Bu bir acil durumdur; hemen ameliyathanede boşaltılması, nadiren nefes yolunun güvenceye alınması (entübasyon veya trakeotomi) gerekebilir.
- **Patoloji sonucunun ön tanıdan farklı çıkması** — Taş veya iltihap düşünülen bir bezde bile kesin patoloji beklenmedik bir tümör gösterebilir. Kötü huylu bir tümör saptanırsa boyun lenf bezlerinin çıkarılması, radyoterapi gibi ek tedaviler gerekebilir.
- **Ağız kuruluğu** — Tek bezin çıkarılması çoğu hastada fark edilmez; ancak daha önce radyoterapi almış, belirli romatizmal hastalıkları olan veya ağız kuruluğu yapan ilaçlar kullanan hastalarda ağız kuruluğu belirginleşebilir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Boyunda hızla artan şişlik**, özellikle **nefes alma veya yutma güçlüğü** ile birlikteyse (acil durum — hemen 112'yi arayınız)
- Dren veya yara yerinden **durmayan kanama**
- **38,5 °C üzerinde ateş**, yarada artan kızarıklık, ağrı, ısı artışı veya iltihaplı akıntı
- Dilde veya ağız tabanında belirgin şişlik
- Konuşmada veya yutmada **yeni ortaya çıkan belirgin zorluk**

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Yara bölgesini ilk 48 saat ıslatmayınız; sonrasında size anlatıldığı şekilde kısa duş alabilirsiniz.
- İlk günlerde yumuşak ve ılık gıdalar tercih ediniz; ağız hijyeninize dikkat ediniz ve bol sıvı alınız.
- İzi en az 6 ay güneşten koruyunuz (yüksek faktörlü güneş kremi).
- Patoloji sonucunu ve takip planını mutlaka hekiminizle görüşünüz.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.

☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.

☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.

☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.

☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.

☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.

☐ Kesin tanının ameliyat sonrası patoloji ile konacağını ve sonuca göre ek tedavi gerekebileceğini anladım.

☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**

☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.